

Miesta účinku diuretík pozdĺž nefrónu.

Prehľad tried diuretík, miesta účinku, dávkových ekvivalencií a zásad pri diuretickej rezistencii. Pri renálnej diéte pozri [plánovač renálnej diéty](#).

Triedy a miesto účinku

Trieda	Zástupcovia	Miesto / cieľ
Slučkové	Furosemid, torasemid, bumetanid	Hrubé vzostupné raménko (NKCC2)
Tiazidové / tiazidom podobné	Hydrochlorotiazid, chlortalidón, indapamid, metolazón	Distálny stočený tubulus (NCC)
Antagonisty mineralokortikoidov (MRA)	Spironolaktón, eplerenón, finerenón*	Zberný kanálik — aldosterónový receptor
Blokátory ENaC	Amilorid, triamterén	Zberný kanálik — epitelový Na kanál
Inhibítory karboanhydrázy	Acetazolamid	Proximálny tubulus
Osmotické	Manitol	Celý nefrón (osmóza)
Vaptany (akvaretiká)	Tolvaptan	Zberný kanálik — V2 receptor (voľná voda)

* Finerenón je nesteroidný MRA — používa sa primárne ako **nefroprotektívum** pri CKD (nie ako diuretikum).

Dávkové ekvivalencie — slučkové diuretiká

Liek	Ekvivalentná dávka	Biologická dostupnosť (p.o.)
Furosemid	40 mg	~50 % (kolísavá, pri edéme čreva ↓)
Torasemid	10–20 mg	~80–100 % (stabilná)
Bumetanid	1 mg	~80–100 %

Furosemid p.o. : i.v. = 2 : 1 (40 mg p.o. ≈ 20 mg i.v.). Pri kolísavej absorpcii uprednostni torasemid alebo i.v. podanie.

Dávkové ekvivalencie — tiazidy a MRA

Liek	Približná ekvivalencia / poznámka
Hydrochlorotiazid 25 mg	Referenčná dávka
Chlortalidón 12,5–25 mg	Účinnejší a dlhšie pôsobiaci (~1,5–2×), výhodný pri hypertenzii
Indapamid 1,5–2,5 mg	Metabolicky neutrálnejší
Spironolaktón 25–50 mg	≈ eplerenón 50 mg; spironolaktón má antiandrogénne NÚ (gynekomastia)

Diuretická rezistencia — princípy

- **Prekročiť prah:** slučkové diuretiká majú prahovú dávku — poddávkovanie nezaberie. Pri

CKD/srdcovom zlyhaní treba vyššiu jednorazovú dávku.

- **Sekvenčná blokáda nefrónu:** pridaj tiazid (napr. metolazón alebo chlortalidón) k slučkovému pri rezistencii.
- **Tiazidy pri nízkom eGFR:** tradične menej účinné pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m²; metolazón a chlortalidón si časť účinku zachovávajú, využívajú sa v kombinácii.
- **Kontinuálna infúzia** slučkového diuretika môže byť účinnejšia než bolusy pri ťažkom edéme.
- Pri hypoalbuminémii a nefrotickom syndróme je odpoveď znížená — rieš aj základnú príčinu.

Monitorovanie a nežiaduce účinky

Trieda	Sledovať
Slučkové	Hypokaliémia, hypomagneziémia, hyponatrémia, hypovolémia, ↑ kreatinín, ↑ urát (dna), ototoxicita pri vysokých i.v. dávkach
Tiazidy	Hyponatrémia (typická!), hypokaliémia, hyperkalciémia, hyperurikémia, hyperglykémia, dyslipidémia
MRA / ENaC blokátory	Hyperkaliémia (najmä s RAAS-blokátorom alebo pri CKD), gynekomastia (spironolaktón)
Acetazolamid	Metabolická acidóza (NAGMA), hypokaliémia
Tolvaptan	Rýchla korekcia Na ⁺ (riziko ODS), smäd, hepatotoxicita (ADPKD)

Zdroj: Ellison DH, Felker GM. *Diuretic Treatment in Heart Failure, N Engl J Med 2017; ESC a štandardné nefrologické/kardiologické odporúčania. Dávky over vždy podľa platného SPC. Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.*

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-diuretika> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.